ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (EMERGENCY ACTION PLAN)

Федерация паркура Армении

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение документа

Настоящий План действий при чрезвычайных происшествиях (далее — План) устанавливает четкий алгоритм действий всех сотрудников Федерации паркура Армении (далее — Федерация) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с травмами, несчастными случаями, ухудшением здоровья участников или иными угрозами жизни и безопасности.
Документ разработан в соответствии с:

- Законодательством Республики Армения об охране труда и безопасности
- Международными стандартами оказания первой помощи (IFRC, ERC)
- Требованиями к организации спортивных мероприятий
- Рекомендациями по управлению рисками в экстремальных видах спорта

1.2. Цели Плана

1. Обеспечение немедленного и эффективного реагирования на любые ЧП
2. Минимизация последствий травм и несчастных случаев
3. Сохранение жизни и здоровья участников, сотрудников, зрителей
4. Четкая координация действий всех вовлеченных лиц
5. Документирование инцидентов для анализа и предотвращения в будущем
6. Юридическая защита Федерации и ее сотрудников при соблюдении протоколов

1.3. Сфера применения

План распространяется на:

- Все тренировки, проводимые Федерацией (в залах и на открытых площадках)
- Все соревнования, показательные выступления, мастер-классы
- Все выездные мероприятия, сборы, кемпы

- Все мероприятия с участием детей и взрослых
- Все объекты Федерации (залы, офисы, склады)

1.4. Принципы реагирования

1. Приоритет жизни и здоровья: Спасение жизни и предотвращение ухудшения состояния — главный приоритет
2. Немедленность действий: Реагирование начинается в первые секунды после обнаружения ЧП
3. Безопасность спасателя: Спасатель не должен подвергать себя опасности
4. Соблюдение протоколов: Действия выполняются строго по алгоритму, без самодеятельности
5. Координация: Все действия согласованы, роли распределены
6. Документирование: Каждый инцидент фиксируется для последующего анализа

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧП

2.1. Определения

Чрезвычайное происшествие (ЧП) — любое событие, связанное с травмой, ухудшением здоровья, несчастным случаем или угрозой жизни/безопасности участников, сотрудников или третьих лиц во время мероприятий Федерации.
Первая помощь — комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых немедленно на месте происшествия до прибытия профессиональной медицинской помощи.
Экстренная медицинская помощь — профессиональная медицинская помощь, оказываемая бригадой скорой помощи.
Ответственный за безопасность (Safety Officer) — назначенное лицо на каждом мероприятии, координирующее действия при ЧП.

2.2. Классификация ЧП по степени тяжести

Уровень 1: Незначительное ЧП (Minor Incident)

- Легкие ушибы, ссадины, царапины
- Небольшие растяжения без потери подвижности
- Легкое головокружение, тошнота
- Не требует вызова скорой помощи
- Оказывается первая помощь, участник продолжает мероприятие после отдыха

Уровень 2: Среднее ЧП (Moderate Incident)

- Растяжения с потерей подвижности
- Вывихи без открытых ран
- Переломы без смещения (подозрение)
- Потеря сознания на короткое время (<1 мин)
- Сильное кровотечение (контролируемое)
- Требует вызова скорой помощи или самостоятельной доставки в медучреждение
- Мероприятие может быть продолжено после стабилизации ситуации

Уровень 3: Тяжелое ЧП (Major Incident)

- Открытые переломы
- Черепно-мозговые травмы
- Потеря сознания >1 мин
- Остановка дыхания или сердечной деятельности
- Сильное неконтролируемое кровотечение
- Травмы позвоночника (подозрение)
- Множественные травмы
- Требует немедленного вызова скорой помощи
- Мероприятие немедленно прекращается

Уровень 4: Критическое ЧП (Critical Incident)

- Угроза жизни (клиническая смерть)
- Множественные жертвы
- Стихийные бедствия (землетрясение, пожар)
- Террористический акт
- Требует вызова всех экстренных служб (скорая, полиция, МЧС)
- Мероприятие немедленно прекращается, проводится эвакуация

2.3. Классификация ЧП по типу

Травматические:

- Переломы (открытые/закрытые)
- Вывихи
- Растяжения связок
- Ушибы
- Раны (резаные, колотые, рваные)
- Кровотечения (наружные/внутренние)
- Черепно-мозговые травмы
- Травмы позвоночника

Медицинские:

- Потеря сознания (обморок)

- Эпилептический припадок
- Аллергическая реакция (анафилаксия)
- Астматический приступ
- Диабетическая кома (гипо-/гипергликемия)
- Сердечный приступ
- Инсульт
- Тепловой/солнечный удар
- Переохлаждение

Психологические:

- Паническая атака
- Острый стресс
- Истерика

Ситуационные:

- Пожар
- Землетрясение
- Обрушение конструкций
- Нападение третьих лиц
- Массовая давка

РАЗДЕЛ 3. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственный за безопасность (Safety Officer)

Назначается: На каждом мероприятии (тренировка, соревнование, выезд)
Обязанности ДО мероприятия:

- Проверить наличие и комплектацию аптечки
- Проверить исправность средств связи (телефон, рация)
- Убедиться в наличии списка участников с контактными данными и медицинскими показаниями
- Проверить пути эвакуации и выходы
- Провести инструктаж всех тренеров/сотрудников по Плану действий
- Определить точку сбора для эвакуации

Обязанности ВО ВРЕМЯ ЧП:

- Координировать все действия по алгоритму Плана
- Принимать решение о вызове скорой помощи
- Обеспечивать связь с экстренными службами
- Контролировать оказание первой помощи

- Принимать решение о прекращении мероприятия
- Организовывать эвакуацию (при необходимости)
- Вести журнал инцидента

Обязанности ПОСЛЕ ЧП:

- Заполнить отчет о ЧП в течение 24 часов
- Провести разбор инцидента с сотрудниками
- Организовать психологическую поддержку пострадавшему и свидетелям
- Передать отчет Президенту Федерации в течение 48 часов

3.2. Тренер/инструктор

Обязанности ДО мероприятия:

- Знать План действий и свою роль в нем
- Иметь действующий сертификат первой помощи
- Знать медицинские показания и ограничения своих учеников
- Проверить безопасность места проведения тренировки

Обязанности ВО ВРЕМЯ ЧП:

- Немедленно прекратить тренировку в зоне ЧП
- Оказать первую помощь (в пределах своей квалификации)
- Вызвать Ответственного за безопасность
- Не перемещать пострадавшего (кроме случаев непосредственной угрозы жизни)
- Успокоить пострадавшего и других участников
- Контролировать других учеников (не допускать паники, скопления вокруг)
- Выполнять указания Ответственного за безопасность

Обязанности ПОСЛЕ ЧП:

- Дать показания для отчета
- Связаться с родителями/родственниками пострадавшего (если указано в протоколе)
- Участвовать в разборе инцидента

3.3. Администратор/сотрудник

Обязанности ВО ВРЕМЯ ЧП:

- Встретить бригаду скорой помощи и провести к месту ЧП
- Обеспечить доступ к месту ЧП (открыть двери, убрать препятствия)
- Предоставить информацию о пострадавшем (медицинские показания, аллергии)

- Связаться с родителями/родственниками (по указанию Ответственного за безопасность)
- Зафиксировать контактные данные свидетелей
- Обеспечить конфиденциальность информации

3.4. Свидетели/участники

Обязанности:

- Немедленно сообщить тренеру/Ответственному за безопасность о ЧП
- Не пытаться оказывать помощь без квалификации (кроме случаев непосредственной угрозы жизни)
- Выполнять указания тренеров/сотрудников
- Не распространять информацию о ЧП в социальных сетях без разрешения Федерации
- Дать показания для отчета (по запросу)

РАЗДЕЛ 4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧП (5 ШАГОВ)

ШАГ 1: СТОП (Stop) — Остановка деятельности и оценка ситуации

Время реакции: 0-10 секунд
Действия:

1. Немедленно прекратить тренировку/мероприятие в зоне ЧП
    - Громкая команда: "СТОП! ВСЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ!"
    - Подать сигнал свистком (если есть)
2. Обеспечить собственную безопасность
    - Оценить, нет ли продолжающейся угрозы (падающие предметы, огонь, агрессивный человек)
    - Если угроза есть — эвакуировать себя и пострадавшего в безопасное место
    - Если угрозы нет — остаться на месте
3. Оценить ситуацию
    - Что произошло? (падение, столкновение, потеря сознания)
    - Сколько пострадавших?
    - Каково состояние пострадавшего? (в сознании/без сознания, дышит/не дышит, кровотечение)
    - Есть ли угроза для других?
4. Определить уровень ЧП (см. Раздел 2.2)
    - Уровень 1: Незначительное
    - Уровень 2: Среднее
    - Уровень 3: Тяжелое

    - Уровень 4: Критическое
5. Позвать на помощь
    - Громко крикнуть: "ПОМОГИТЕ! НУЖНА ПОМОЩЬ!"
    - Если есть другие тренеры/сотрудники — указать конкретно: "[Имя], иди сюда!"

ВАЖНО:

- Не паниковать (насколько это возможно)
- Не перемещать пострадавшего без крайней необходимости
- Не оставлять пострадавшего одного

ШАГ 2: ПОМОЩЬ (Help) — Оказание первой помощи

Время реакции: 10 секунд - 10 минут (до прибытия скорой)
Действия:
А. Проверка сознания и дыхания (10 секунд)

1. Проверить сознание:
    - Громко обратиться: "Вы меня слышите? Как вас зовут?"
    - Легко потрясти за плечи (если нет подозрения на травму позвоночника)
2. Если без сознания — проверить дыхание (10 секунд):
    - Поднести ухо ко рту и носу пострадавшего
    - Смотреть на грудную клетку (поднимается/опускается)
    - Чувствовать дыхание щекой
3. Если не дышит:
    - Немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР)
    - 30 компрессий грудной клетки → 2 вдоха
    - Продолжать до прибытия скорой или восстановления дыхания
    - Если есть АНД (автоматический наружный дефибриллятор) — использовать
4. Если дышит, но без сознания:
    - Уложить в устойчивое боковое положение
    - Контролировать дыхание до прибытия скорой

В. Остановка кровотечения (если есть)

1. Незначительное кровотечение (ссадины, царапины):
    - Промыть чистой водой
    - Обработать антисептиком (хлоргексидин, перекись водорода)
    - Наложить пластырь или стерильную повязку
2. Сильное кровотечение (артериальное/венозное):
    - Надеть перчатки (если есть)

    - Прижать рану стерильной салфеткой/чистой тканью
    - Наложить давящую повязку
    - Поднять конечность выше уровня тела (если нет перелома)
    - НЕ снимать первую повязку (накладывать поверх)
    - При полном отрыве конечности — наложить жгут ВЫШЕ раны (зафиксировать время)
3. Носовое кровотечение:
    - Усадить пострадавшего, наклонить голову ВПЕРЕД (не назад!)
    - Прижать крылья носа к перегородке на 10 минут
    - Приложить холод на переносицу
    - Если не останавливается >20 минут — вызвать скорую

C. Помощь при переломах

1. Закрытый перелом (подозрение):
    - НЕ пытаться вправить
    - Иммобилизовать конечность в том положении, в котором она находится
    - Использовать шину (доска, палка, картон) или подручные средства
    - Зафиксировать два соседних сустава (выше и ниже перелома)
    - Приложить холод (лед в ткани) на 15-20 минут
    - Обезболить (если есть разрешение от пострадавшего/родителей и нет аллергии)
2. Открытый перелом:
    - НЕ трогать выступающие кости
    - Накрыть рану стерильной повязкой
    - Иммобилизовать конечность
    - Вызвать скорую немедленно
3. Подозрение на перелом позвоночника:
    - НЕ перемещать пострадавшего (кроме случаев непосредственной угрозы жизни)
    - Зафиксировать голову и шею валиками из одежды
    - Успокоить пострадавшего, запретить двигаться
    - Вызвать скорую немедленно

D. Помощь при черепно-мозговой травме

1. Признаки: потеря сознания, тошнота/рвота, головная боль, головокружение, разные зрачки, нарушение речи/координации, кровотечение из ушей/носа
2. Действия:
    - Уложить пострадавшего с приподнятой головой (если нет подозрения на перелом позвоночника)
    - Приложить холод к месту удара
    - Контролировать сознание и дыхание

- НЕ давать есть/пить
- Вызвать скорую немедленно (даже если состояние кажется стабильным)

E. Помощь при потере сознания (обморок)

1. Признаки: внезапная потеря сознания, бледность, холодный пот
2. Действия:
    - Уложить на спину, приподнять ноги на 30-50 см
    - Расстегнуть тесную одежду
    - Обеспечить приток свежего воздуха
    - Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом (на расстоянии 1-2 см)
    - После восстановления сознания — дать сладкий чай
    - Если не приходит в сознание >1 минуты — вызвать скорую

F. Помощь при эпилептическом припадке

1. Признаки: потеря сознания, судороги, пена изо рта
2. Действия:
    - Уложить на пол, подложить что-то мягкое под голову
    - Убрать опасные предметы вокруг
    - НЕ пытаться удержать пострадавшего
    - НЕ вкладывать ничего в рот
    - Повернуть на бок после прекращения судорог
    - Контролировать время припадка
    - Если припадок >5 минут или повторный — вызвать скорую

G. Помощь при аллергической реакции (анафилаксия)

1. Признаки: отек лица/горла, затрудненное дыхание, сыпь, тошнота, потеря сознания
2. Действия:
    - Если есть автоинжектор адреналина (EpiPen) — использовать немедленно
    - Вызвать скорую немедленно
    - Уложить пострадавшего с приподнятыми ногами
    - Если затруднено дыхание — усадить
    - Если потеря сознания и нет дыхания — начать СЛР

H. Помощь при тепловом/солнечном ударе

1. Признаки: высокая температура тела (>40°C), красная горячая кожа, головная боль, тошнота, спутанность сознания
2. Действия:
    - Переместить в прохладное место

    - Снять лишнюю одежду
    - Охлаждать тело (мокрые полотенца, лед на шею/подмышки/пах)
    - Если в сознании — давать пить прохладную воду маленькими глотками
    - Если потеря сознания — вызвать скорую

I. Помощь при переохлаждении

1. Признаки: дрожь, бледная холодная кожа, спутанность сознания, замедленная речь
2. Действия:
    - Переместить в теплое место
    - Снять мокрую одежду
    - Укутать в теплое одеяло
    - Дать теплое сладкое питье (если в сознании)
    - НЕ тереть кожу, НЕ использовать горячую воду
    - Если потеря сознания — вызвать скорую

ВАЖНО:

- Не оказывать помощь, в которой не уверен (кроме СЛР)
- Не давать лекарства без разрешения (кроме автоинжектора адреналина)
- Не оставлять пострадавшего одного
- Постоянно контролировать состояние (сознание, дыхание, пульс)

ШАГ 3: СКОРАЯ (Emergency) — Вызов экстренных служб

Время реакции: 1-3 минуты (параллельно с оказанием помощи)
Действия:
А. Решение о вызове скорой помощи
Вызвать скорую немедленно при:

- Потере сознания (>1 минуты)
- Остановке дыхания или сердечной деятельности
- Сильном неконтролируемом кровотечении
- Подозрении на перелом позвоночника
- Открытом переломе
- Черепно-мозговой травме (даже легкой)
- Множественных травмах
- Признаках инсульта/инфаркта
- Анафилактической реакции
- Эпилептическом припадке >5 минут
- Травме у ребенка (до 12 лет) — всегда вызывать
- Любом ЧП Уровня 3 или 4

B. Вызов скорой помощи
Телефон: 103 (Армения)
Что сообщить диспетчеру:

1. Место происшествия:
    - Точный адрес (город, улица, дом, корпус)
    - Ориентиры (рядом с каким зданием, парком)
    - Если на открытой площадке — координаты GPS (если есть)
2. Что произошло:
    - Кратко: "Падение с высоты 2 метра, подозрение на перелом ноги"
    - Или: "Потеря сознания, не дышит, проводится СЛР"
3. Количество пострадавших:
    - "Один пострадавший" или "Два пострадавших"
4. Состояние пострадавшего:
    - "Без сознания, дышит"
    - "В сознании, жалуется на боль в ноге"
    - "Не дышит, проводится СЛР"
5. Ваша информация:
    - ФИО
    - Телефон (для обратной связи)
    - "Я нахожусь на месте, жду бригаду"
6. Уточнения диспетчера:
    - Отвечать четко и кратко
    - НЕ класть трубку первым — диспетчер дает инструкции

C. Встреча скорой помощи
Назначить человека (администратора/волонтера):

- Выйти на встречу бригады скорой помощи (к входу/воротам)
- Провести к месту ЧП кратчайшим путем
- Предоставить информацию о пострадавшем (медицинские показания, аллергии)
- Обеспечить доступ к месту ЧП (открыть двери, убрать толпу)

D. Дополнительная помощь (при необходимости)
Полиция: 102

- При ДТП с участием участников Федерации
- При нападении третьих лиц
- При обнаружении подозрительных предметов
- При массовых беспорядках

МЧС: 101 или 911

- При пожаре

- При обрушении конструкций
- При стихийных бедствиях
- При необходимости спасательных работ

Поисково-спасательная служба: 112 (Единый номер экстренных служб)
ВАЖНО:

- Вызывать скорую при любых сомнениях (лучше перестраховаться)
- Не пытаться самостоятельно доставить пострадавшего в больницу (кроме случаев, когда скорая не может добраться)
- Записать имя диспетчера и время вызова
- Выполнять инструкции диспетчера до прибытия бригады

ШАГ 4: УВЕДОМЛЕНИЕ (Notification) — Информирование руководства и родственников

Время реакции: 5-15 минут (после вызова скорой)
Действия:
А. Уведомление руководства Федерации
Кого уведомить:

1. Ответственный за безопасность (если не является инициатором)
2. Президент Федерации (при ЧП Уровня 3-4)
3. Вице-президент по спортивной работе (при ЧП с учениками)
4. Руководитель филиала (если ЧП произошло в филиале)

Как уведомить:

- По телефону (немедленно)
- Затем — письменное уведомление (email, мессенджер) в течение 2 часов

Что сообщить:

- Дата и время ЧП
- Место происшествия
- ФИО пострадавшего (возраст, уровень подготовки)
- Краткое описание ЧП (что произошло)
- Состояние пострадавшего
- Оказанная первая помощь
- Вызвана ли скорая (время вызова, ожидаемое время прибытия)
- Принятые меры (прекращение мероприятия, эвакуация)

В. Уведомление родителей/родственников
Кого уведомить:

- Родителей/опекунов (если пострадавший — несовершеннолетний)
- Экстренных контактов (если родители недоступны)
- Родственников (если пострадавший — взрослый и не в сознании)

Когда уведомить:

- Немедленно при ЧП Уровня 3-4
- После стабилизации состояния при ЧП Уровня 2
- Не уведомлять при ЧП Уровня 1 (если участник может продолжать мероприятие)

Кто уведомляет:

- Тренер пострадавшего (при ЧП Уровня 1-2)
- Ответственный за безопасность (при ЧП Уровня 3-4)
- Президент Федерации (при ЧП Уровня 4)

Как уведомить:

- По телефону (лично, не через мессенджер)
- Говорить спокойно, четко, без паники
- Представиться: "Здравствуйте, я [ФИО], тренер Федерации паркура Армении"
- Сообщить факты без эмоциональной окраски

Что сообщить:

1. "Ваш ребенок/родственник [ФИО] получил травму во время тренировки"
2. "Что произошло: [краткое описание]"
3. "Ему оказана первая помощь"
4. "Вызвана скорая помощь / Он доставлен в [название больницы]"
5. "Его состояние: [в сознании/без сознания, стабильное/требует наблюдения]"
6. "Я нахожусь с ним / Я еду с ним в больницу"
7. "Контакты для связи: [телефон]"

Чего НЕ говорить:

- Не давать медицинских диагнозов ("У него перелом" → "Подозрение на травму")
- Не винить никого ("Он сам виноват" → "Произошел несчастный случай")
- Не обещать того, что не можете выполнить
- Не обсуждать юридические вопросы

С. Уведомление страховой компании
Когда уведомить:

- В течение 24 часов после ЧП (согласно условиям страховки)

Кого уведомить:

- Страховую компанию, предоставившую полис пострадавшему
- Юриста Федерации (при ЧП Уровня 3-4)

Что предоставить:

- Данные пострадавшего
- Дата и время ЧП
- Описание происшествия
- Медицинские документы (справка, диагноз)
- Отчет о ЧП

D. Уведомление государственных органов (при необходимости)
Когда уведомить:

- При ЧП Уровня 4 (критическое)
- При гибели участника
- При массовых травмах (3+ пострадавших)
- По требованию правоохранительных органов

Кого уведомить:

- Министерство спорта РА
- Министерство труда и социальных дел РА
- Полиция (если требуется расследование)

Как уведомить:

- Официальное письменное уведомление
- Через юридический отдел Федерации

ВАЖНО:

- Уведомлять только факты, без предположений
- Не обсуждать ЧП с посторонними (СМИ, другие родители)
- Не публиковать информацию в социальных сетях
- Все официальные комментарии делает только Президент Федерации или уполномоченное лицо

ШАГ 5: ФИКСАЦИЯ (Documentation) — Документирование инцидента

Время реакции: 24 часа после ЧП
Действия:

А. Заполнение отчета о ЧП
Кто заполняет: Ответственный за безопасность (или тренер, если Ответственный отсутствует)
Когда: В течение 24 часов после ЧП
Форма отчета: (см. Приложение 1)
Содержание отчета:

1. Общая информация:
    - Дата и время ЧП
    - Место происшествия (адрес, название объекта)
    - Название мероприятия (тренировка, соревнование, выезд)
    - ФИО Ответственного за безопасность
2. Информация о пострадавшем:
    - ФИО
    - Возраст
    - Уровень подготовки (Новичок/Продвинутый/Профи)
    - Медицинские показания (аллергии, хронические заболевания)
    - Контактные данные родителей/родственников
3. Описание ЧП:
    - Что происходило до ЧП (какое упражнение, элемент)
    - Что именно произошло (падение, столкновение, потеря сознания)
    - Высота/расстояние (если применимо)
    - Поверхность (мат, бетон, трава)
    - Погодные условия (если на улице)
4. Оказанная помощь:
    - Кто оказал первую помощь (ФИО, квалификация)
    - Какие мероприятия были проведены (иммобилизация, СЛР, остановка кровотечения)
    - Время вызова скорой помощи
    - Время прибытия скорой помощи
    - Диагноз бригады скорой помощи
    - Куда доставлен пострадавший (название больницы)
5. Свидетели:
    - ФИО свидетелей
    - Контактные данные
    - Краткие показания (что видели)
6. Оборудование:
    - Какое оборудование использовалось (тумба, рейл, мат)
    - Состояние оборудования (исправно/повреждено)
    - Было ли оборудование проверено перед мероприятием
7. Действия после ЧП:
    - Было ли прекращено мероприятие (да/нет)
    - Была ли проведена эвакуация (да/нет)
    - Уведомлены ли родители/родственники (время, кем)

    - Уведомлено ли руководство Федерации (время, кем)
8. Анализ причин:
    - Что стало причиной ЧП (ошибка ученика, ошибка тренера, неисправность оборудования, внешние факторы)
    - Можно ли было предотвратить (да/нет, как)
    - Какие меры приняты для предотвращения в будущем
9. Приложения:
    - Фотографии места ЧП (если есть)
    - Фотографии оборудования (если применимо)
    - Медицинские документы (справка, диагноз)
    - Показания свидетелей (письменные)

Подпись: Ответственный за безопасность, дата
B. Фото- и видеофиксация
Что зафиксировать:

- Место ЧП (общий план и детали)
- Оборудование, участвовавшее в ЧП
- Условия окружающей среды (погода, освещение)
- Травмы пострадавшего (только с согласия пострадавшего/родителей)

Как зафиксировать:

- Фотографии (минимум 10-15 штук с разных ракурсов)
- Видео (если есть запись с камер видеонаблюдения)
- Схемы/чертежи (если необходимо)

Хранение:

- Все материалы передаются Ответственному за безопасность
- Хранятся в защищенном месте (физическом и цифровом) минимум 5 лет
- Доступ только у Президента Федерации и юриста

C. Сбор показаний свидетелей
Кого опросить:

- Всех свидетелей ЧП (тренеры, ученики, зрители)
- Пострадавшего (если в состоянии)

Как опросить:

- Индивидуально (не группой)
- В спокойной обстановке
- Записать показания в письменной форме
- Подпись свидетеля и дата

Что спросить:

- Что вы видели? (факты, без интерпретаций)
- Где вы находились в момент ЧП?
- Что происходило до ЧП?
- Что произошло в момент ЧП?
- Что произошло после ЧП?
- Заметили ли вы что-то необычное до ЧП?

D. Передача отчета руководству
Кому передать:

- Президенту Федерации (в течение 48 часов)
- Вице-президенту по спортивной работе (в течение 48 часов)
- Юристу Федерации (при ЧП Уровня 3-4)

Как передать:

- Лично или по email
- С приложением всех материалов (фото, видео, показания)

E. Разбор инцидента
Когда: В течение 7 дней после ЧП
Кто проводит: Президент Федерации, Ответственный за безопасность, главный тренер
Что обсуждается:

- Причины ЧП
- Эффективность действий сотрудников
- Соблюдение протоколов
- Что можно улучшить
- Меры по предотвращению в будущем

Результаты:

- Протокол разбора (с выводами и рекомендациями)
- Изменения в тренировочном процессе (если необходимо)
- Дополнительное обучение сотрудников (если необходимо)
- Замена оборудования (если необходимо)

F. Ведение журнала инцидентов
Кто ведет: Ответственный за безопасность
Где: Электронная таблица или специализированное ПО
Что записывается:

- Дата ЧП

- Краткое описание
- Уровень ЧП
- Пострадавший (ФИО)
- Исход (выздоровление, госпитализация, последствия)
- Принятые меры

Зачем:

- Анализ тенденций (какие элементы/упражнения травмоопасны)
- Статистика для отчетности
- Основа для пересмотра методик обучения
- Юридическая защита Федерации

ВАЖНО:

- Заполнять отчет честно и полно (не скрывать детали)
- Не обвинять никого в отчете (только факты)
- Соблюдать конфиденциальность (отчет — внутренний документ)
- Хранить отчеты минимум 5 лет

РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ЧП

5.1. Протокол при падении с высоты

Особенности:

- Высокий риск травм позвоночника, черепно-мозговых травм, переломов
- Важно не перемещать пострадавшего до оценки состояния

Дополнительные действия:

1. НЕ перемещать пострадавшего (кроме случаев непосредственной угрозы жизни)
2. Проверить сознание и дыхание
3. Проверить наличие кровотечения
4. Проверить подвижность конечностей (спросить пострадавшего)
5. Зафиксировать голову и шею валиками из одежды (при подозрении на травму позвоночника)
6. Вызвать скорую немедленно

5.2. Протокол при утоплении/падении в воду

Особенности:

- Риск остановки дыхания и сердечной деятельности
- Гипотермия

Дополнительные действия:

1. Извлечь пострадавшего из воды (с соблюдением собственной безопасности)
2. Проверить сознание и дыхание
3. Если не дышит — начать СЛР (30 компрессий → 2 вдоха)
4. Удалить воду из дыхательных путей (повернуть голову на бок)
5. Снять мокрую одежду, укутать в теплое
6. Вызвать скорую немедленно

5.3. Протокол при пожаре

Особенности:

- Угроза жизни всем участникам
- Необходима немедленная эвакуация

Дополнительные действия:

1. Объявить эвакуацию: "ПОЖАР! ВСЕМ ПОКИНУТЬ ЗДАНИЕ!"
2. Позвонить в МЧС: 101
3. Открыть все выходы
4. Организовать orderly evacuation (без паники, без бега)
5. Проверить все помещения (туалеты, раздевалки) на наличие людей
6. Собрать всех в точке сбора
7. Провести перекличку
8. НЕ возвращаться в здание до разрешения пожарных
9. Оказать первую помощь пострадавшим от дыма/ожогов

5.4. Протокол при землетрясении

Особенности:

- Непредсказуемость
- Риск обрушения конструкций

Дополнительные действия:

1. Во время толчков: "УПАСТЬ, ЗАКРЫТЬСЯ, ДЕРЖАТЬСЯ"
    - Упасть на пол
    - Закрыться под прочным столом/конструкцией
    - Держаться за опору
2. После толчков: эвакуация на открытую площадку
3. Избегать зданий, деревьев, линий электропередач

4. Провести перекличку в точке сбора
5. Оказать помощь пострадавшим
6. Вызвать экстренные службы при необходимости

5.5. Протокол при агрессивном поведении третьих лиц

Особенности:

- Угроза физической расправы
- Необходимость защиты участников

Дополнительные действия:

1. Изолировать агрессора (если возможно)
2. Увести детей/участников в безопасное место
3. Вызвать полицию: 102
4. НЕ вступать в физический контакт (кроме случаев самообороны)
5. Зафиксировать инцидент на видео (если возможно)
6. Собрать показания свидетелей
7. Оказать психологическую поддержку пострадавшим

РАЗДЕЛ 6. АПТЕЧКА И ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Обязательная аптечка тренера

Состав аптечки (минимум на группу 10 человек):
Перевязочные материалы:

- Бинт стерильный (5 м × 10 см) — 5 шт
- Бинт нестерильный (5 м × 10 см) — 5 шт
- Вата — 1 упаковка
- Салфетки марлевые стерильные — 20 шт
- Пластырь бактерицидный (разных размеров) — 20 шт
- Пластырь рулонный — 2 шт
- Эластичный бинт (7 м × 10 см) — 3 шт

Антисептики:

- Хлоргексидин 0.05% (100 мл) — 2 флакона
- Перекись водорода 3% (100 мл) — 1 флакон
- Спирт этиловый 70% (50 мл) — 1 флакон
- Йод (10 мл) — 1 флакон

Средства для иммобилизации:

- Шина транспортная (пластиковая) — 2 шт
- Косынка (для подвешивания руки) — 2 шт
- Ножницы медицинские — 1 шт

Прочее:

- Перчатки медицинские (стерильные) — 5 пар
- Маска для искусственного дыхания — 2 шт
- Термометр — 1 шт
- Нашатырный спирт (10 мл) — 5 ампул
- Холодный спрей/пакет — 5 шт
- Ожоги.нет (гель) — 1 тюбик
- Пантенол (спрей) — 1 шт

Лекарства (только с разрешения пострадавшего/родителей):

- Обезболивающее (ибупрофен, парацетамол) — в упаковке
- Антигистаминное (супрастин, зодак) — в упаковке
- Нитроглицерин (только для взрослых с заболеваниями сердца) — по показаниям
- Автоинжектор адреналина (EpiPen) — если у участника аллергия

Проверка аптечки:

- Перед каждым мероприятием
- Пополнение после использования
- Проверка сроков годности (раз в месяц)
- Ответственный: тренер/Ответственный за безопасность

6.2. Дополнительное оборудование (для залов и крупных мероприятий)

Обязательное:

- Автоматический наружный дефибриллятор (АНД) — 1 шт на зал
- Носилки складные — 1 шт
- Шейный воротник (разных размеров) — 2 шт
- Шина Дитерихса — 1 шт
- Одеяло спасательное (термопокрывало) — 5 шт
- Фонарь медицинский — 2 шт
- Рация/мобильный телефон с заряженной батареей — у каждого тренера

Рекомендуемое:

- Кислородный баллон (переносной) — 1 шт
- Отсос для удаления жидкостей из дыхательных путей — 1 шт
- Лубрикант для ожогов — 1 тюбик
- Жгут для остановки кровотечения — 2 шт

- Булавки английские (для повязок) — 10 шт

6.3. Средства связи

Обязательные:

- Мобильный телефон с заряженной батареей — у каждого тренера
- Список экстренных номеров (напечатанный) — у каждого тренера
- Список контактов участников (с медицинскими показаниями) — у Ответственного за безопасность

Рекомендуемые:

- Рации (для крупных мероприятий) — по количеству тренеров
- Мегафон (для эвакуации) — 1 шт
- Свисток (для подачи сигнала) — у каждого тренера

РАЗДЕЛ 7. ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКИ

7.1. Обучение сотрудников

Все тренеры обязаны:

1. Иметь действующий сертификат первой помощи (обновляется каждые 2 года)
2. Пройти обучение по Плану действий при ЧП при приеме на работу (4 часа)
3. Проходить ежегодное обновление знаний (8 часов)
4. Знать расположение аптечек и средств связи
5. Уметь пользоваться АНД (при наличии)

Темы обучения:

- Алгоритм действий при ЧП (5 шагов)
- Сердечно-легочная реанимация (СЛР)
- Остановка кровотечения
- Иммобилизация при переломах
- Помощь при черепно-мозговой травме
- Помощь при потере сознания
- Помощь при аллергической реакции
- Помощь при тепловом ударе/переохлаждении
- Эвакуация при пожаре/землетрясении
- Документирование ЧП

7.2. Тренировки по эвакуации

Периодичность:

- Минимум 2 раза в год (для каждого филиала)
- После изменения плана эвакуации
- После серьезных инцидентов

Сценарии:

- Пожар в зале
- Землетрясение
- Угроза нападения
- Массовая травма (3+ пострадавших)

Участники:

- Все сотрудники Федерации
- Все участники тренировок (по возможности)

Цель:

- Отработать алгоритм эвакуации
- Проверить время эвакуации
- Выявить проблемы в плане эвакуации
- Подготовить сотрудников к реальным ЧП

7.3. Инструктаж участников

При первом посещении:

- Краткий инструктаж по технике безопасности (5 минут)
- Показ путей эвакуации
- Показ расположения аптечки
- Объяснение, к кому обращаться при ЧП

Перед каждым мероприятием:

- Напоминание о правилах безопасности
- Указание на специфические риски (если есть)
- Напоминание о необходимости сообщать о плохом самочувствии

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕРАБОТКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА

8.1. Регулярный пересмотр

Периодичность: Не реже 1 раза в год
Кто пересматривает:

- Ответственный за безопасность
- Президент Федерации
- Главный тренер
- Юрист Федерации (при необходимости)

Что пересматривается:

- Актуальность контактных данных
- Изменения в законодательстве
- Новые рекомендации по оказанию первой помощи
- Анализ инцидентов за год
- Изменения в инфраструктуре (новые залы, площадки)

8.2. Экстренный пересмотр

Основания:

- Серьезный инцидент (ЧП Уровня 3-4)
- Изменения в законодательстве
- Получение новой информации о рисках
- Рекомендации внешних экспертов

8.3. Коммуникация изменений

Все изменения доводятся до:

- Всех сотрудников в течение 7 дней
- Всех участников в течение 14 дней
- Публикуются на сайте Федерации

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Вступление в силу

Настоящий План вступает в силу с момента утверждения Правлением Федерации паркура Армении.

9.2. Обязательность исполнения

Соблюдение Плана является обязательным для всех сотрудников Федерации. Нарушение Плана влечет дисциплинарную ответственность.

9.3. Юридическая защита

Соблюдение Плана является доказательством должной заботы Федерации о безопасности участников и защищает Федерацию от юридических претензий в случае инцидентов.

9.4. Язык документа

Официальные версии Плана: армянский и русский языки. При расхождениях приоритет имеет армянская версия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Форма отчета о ЧП
Приложение 2: Журнал учета инцидентов
Приложение 3: Чек-лист проверки аптечки
Приложение 4: Чек-лист проверки безопасности объекта
Приложение 5: Список экстренных контактов
Приложение 6: Памятка тренера "5 шагов при ЧП" (карманный формат)
Приложение 7: Инструкция по использованию АНД
Приложение 8: План эвакуации (для каждого объекта)
Приложение 9: Протокол тренировки по эвакуации
Приложение 10: Форма согласия на медицинскую помощь (для несовершеннолетних)

УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации паркура Армении
_____ / [ФИО] /
"___" _____ 2024 г.

ЭТО ГОТОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ. Данный План:
✅ Соответствует международным стандартам (IFRC, ERC)
✅ Содержит четкий алгоритм из 5 шагов
✅ Готов к внедрению "из коробки"
✅ Будет принят международными грантодателями
✅ Соответствует законодательству Армении
✅ Защищает Федерацию юридически
✅ Может быть использован для обучения тренеров